

LE RGO ET LE RGOP CHEZ UN BÉBÉ

Quelle est la différence entre le RGO et le RGOP?

Le RGO (reflux gastro-œsophagien) désigne la remontée du contenu de l'estomac vers l'œsophage (canal alimentaire). Il peut se produire lorsque le muscle reliant l'œsophage à l'estomac ne fonctionne pas adéquatement. Le RGO peut entraîner une régurgitation ou des vomissements fréquents.

Le RGOP (reflux gastro-œsophagien pathologique) est présent lorsque les symptômes du RGO sont plus gênants ou plus sévères ou qu'ils entraînent des complications. Les symptômes du RGOP comprennent les vomissements ou la régurgitation accompagnés des signes suivants : très grande irritabilité, refus de s'alimenter, gain pondéral insuffisant, cambrure du dos durant la tétée ou les biberons, difficulté à avaler ou toux/respiration sifflante.

En vous interrogeant sur les symptômes de votre bébé et en effectuant un examen physique, votre médecin peut généralement déterminer si votre bébé est atteint du RGO ou du RGOP, et sera en mesure d'écarter les causes plus graves. Dans la plupart des cas, d'autres tests ne sont pas nécessaires.

Quel est le traitement du RGO et du RGOP?

Chez la majorité des bébés, le RGO ne nécessite pas de traitement médical. Bien que les symptômes de votre bébé puissent vous causer de l'anxiété, rappelez-vous que chez les bébés en bonne santé de 12 mois et moins, la régurgitation :

- est normale et courante;
- peut être fréquente – certains bébés régurgitent au moins six fois par jour;
- commence habituellement avant l'âge de 8 semaines et s'atténue avec le temps – seuls 5 à 10 % des bébés régurgitent encore à l'âge de 12 mois.

Pour le RGO et le RGOP, les mesures suivantes peuvent être utiles :

	Alimentation	Position du bébé
Si vous allaitez	• Renseignez-vous auprès de votre médecin sur l'évaluation de la méthode d'allaitement (si possible).	Évitez de placer votre bébé dans un porte-bébé ou un siège durant la tétée ou les biberons. Il peut être utile de le tenir complètement droit. Couchez votre bébé sur le dos pour le sommeil.
Si le bébé est nourri à la formule	• Demandez à votre professionnel de la santé si la quantité de lait administrée à votre bébé convient à son poids. • Essayez de lui donner des quantités inférieures et plus fréquentes. • Épaississez son lait – en ajoutant une cuillerée à table de céréale de riz sèche par once de formule.	

Médicaments pour le RGOP

Aucun médicament ne doit être administré au bébé qui ne fait que régurgiter. Votre médecin peut envisager d'essayer d'un médicament pendant une courte durée si votre bébé présente des symptômes de RGOP plus graves en plus de la régurgitation (voir la liste des symptômes ci-dessus).

Sources : **1)** Lightdale JR, Gremse DA. Gastroesophageal reflux: management guidance for the pediatrician. *Pediatrics*. 2013;131(5):e1684-1695.; **2)** National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). Gastro-oesophageal reflux disease in children and young people: diagnosis and management. 2015.; **3)** Vandenplas Y. Management of paediatric GERD. *Nature reviews. Gastroenterology & Hepatology*. 2014;11(3):147-157.

